Evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje oral

Unidad 4. Clasificación, descripción y etiología de las alteraciones de la fluidez

ÍNDICE

1. Introducción.....2

2. Clasificación de las alteraciones del lenguaje oral 2

2.1. Alteraciones de la fluidez 2

2.1.1. Introducción..... 2

2.1.2. Disfemia 3

2.1.2.1. Conceptualización y características prototípicas 3

2.1.2.2. Disfluencias vs tartamudez..... 4

2.1.2.3. Manifestaciones de la disfemia 5

2.1.2.4. Taxonomía y prevalencia de la disfemia 6

2.1.2.5. Evaluación de la disfemia en preescolares..... 8

2.1.2.6. Evaluación de la disfemia en escolares 9

2.1.2.7. Principales protocolos de Evaluación de la tartamudez 11

2.1.2.8. Intervención en disfemia: programas de intervención 11

2.1.2.9. Intervención directa en disfemia: tipología de actividades y papel del A.L. 13

2.1.2.10. El rol de las familias 14

BIBLIOGRAFÍA.....15

1. Introducción

Las alteraciones de la fluidez se caracterizan clínicamente por una serie de disfluencias y/o disritmias anormales y persistentes del habla que se identifican con las interrupciones en la producción de determinados sonidos que afectan al ritmo del discurso, ya sea por exceso o por defecto (Coll-Florit et al., 2014).

La fluidez, por su parte, tiene una importancia significativa para que la producción, que es la expresión oral del lenguaje, sea comprendida. Tener una buena fluidez es parte de los parámetros de un lenguaje eficaz, cuyo objetivo es la comunicación.

Teniendo en cuenta lo anterior en esta unidad tiene como objetivos: (I) trabajar con la clasificación general de las alteraciones del lenguaje oral y sus implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje; (II) visualizar la panorámica de todas las alteraciones del lenguaje oral existentes para, posteriormente, hacer especial hincapié, en las alteraciones de la fluidez y, por último, (III) conocer la evaluación e intervención de los diversos trastornos de la fluidez para, como especialistas, poderlos aplicar, teniendo en cuenta sus implicaciones, en el ámbito de la enseñanza.

2. Clasificación de las alteraciones del lenguaje oral

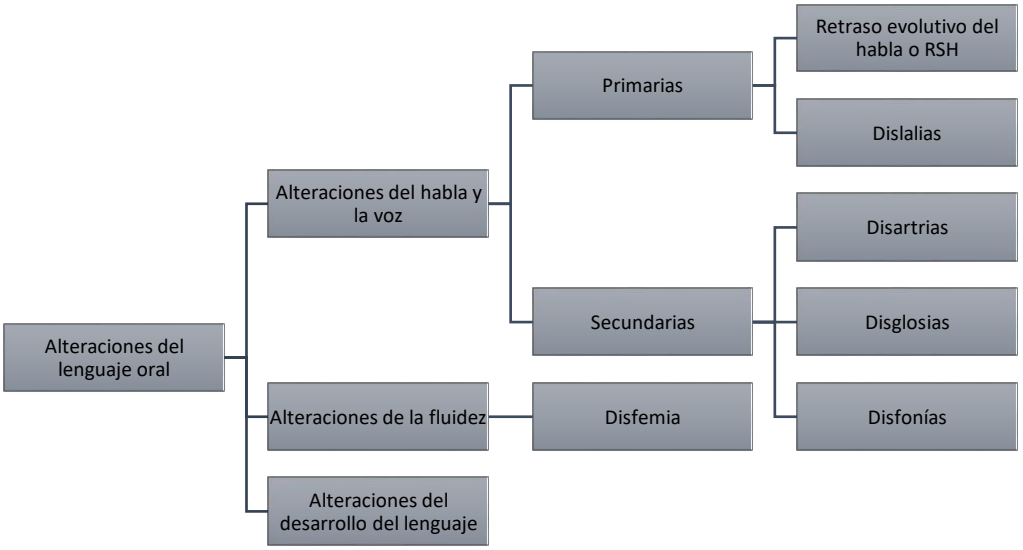
2.1. Alteraciones de la fluidez

2.1.1. Introducción

Como se expuso en puntos anteriores, una de las clasificaciones más utilizadas dentro del campo de las alteraciones del lenguaje oral es la llevada a cabo por Susanibar et al. (2016), quienes las dividien en tres vertientes principales: habla y voz; fluidez y desarrollo del lenguaje (véase Figura 1).

Figura 1.

Clasificación de las alteraciones del lenguaje oral (Susanibar et al., 2016)



2.1.2. Disfemia

2.1.2.1. Conceptualización y características prototípicas

La disfemia es una ruptura de la fluidez del habla, la cual ocurre sin ser planificada por el hablante y sucederá incluso cuando el sujeto sabe perfectamente lo que quiere decir, por ello es considerada una ruptura involuntaria y comprenderla es uno de los mayores desafíos en disciplinas tan dispares como la lingüística, la logopedia o fonoaudiología (Susanibar et al. 2016).

En lo que respecta a sus factores etiológicos, no existe uno único, sino un conjunto de ellos (ambientales, emocionales, relacionados con el desarrollo infantil, relacionados con el aprendizaje) que pueden interaccionar de diferente forma (para más información, consúltese https://www.carm.es/edu/pub/17018_2018/4_contenido.html)

En relación con las características propias de la alteración, puede hablarse de:

- Temblor muscular, variación de los modos de disfemia, bloqueos, repeticiones, gestos de camuflaje, tensión vocal, comportamientos de evitación.
- Retraso en la emisión de las palabras, vergüenza, técnicas de desbloqueo (muecas faciales, aleteo de las ventanas nasales…)
- Rupturas de flujo, las cuales pueden ser, predominantemente, de tres tipos: bloqueos, repeticiones y prolongaciones (véase Figura 1).

Figura 2.

El iceberg de la disfemia



Fuente: TTM/Fundación Española de la Tartamudez(s.f.)

Es importante dejar claro desde el principio que la disfemia también es considerada una alteración del lenguaje. Tanto la fonoaudiología como la terapia del habla asumen al lenguaje como su objeto de estudio. Así, cuando hay rupturas en la fluidez, todo el sistema del lenguaje también se quiebra. La falta de sincronía resultante, si es excesiva y fuera de lo esperado para su comunidad lingüística, podrá ser considerada una alteración de la fluidez (Coll-Florit et al. 2014).

Por último, en cuestiones de delimitación conceptual, el DSM V considera la disfemia como un Trastorno de la Comunicación en general y es descrito como Trastorno de la Fluidez que debe iniciarse en la infancia, en particular. Está clasificada dentro de la sección de Trastornos del Neurodesarrollo (Echeburúa et al. 2014).

2.1.2.2. Disfluencias vs tartamudez

El término disfluencia ha sido frecuentemente utilizado como sinónimo de disfemia, pero, por analogía, la segunda se caracteriza por lo contrario de lo que se define la primera, un habla tartamudeada presenta bloqueos, prolongaciones y repeticiones de sonidos, sílabas y palabras monosilábicas y, además, buena parte de los sujetos presentan concomitantes físicos, alteraciones en el volumen y en la voz, la velocidad y la organización de las estructuras lingüísticas (Susanibar et al. 2016).

Las disfluencias son interrupciones involuntarias en la fluidez natural del habla, como repeticiones de sonidos o sílabas, alargamientos y bloqueos. Son comunes durante el desarrollo infantil temprano (disfluencias evolutivas), pero si persisten, se acompañan de tensión física o generan ansiedad, se clasifican como disfemia o tartamudez.

En este sentido, las disfluencias que persisten de manera característica en los niños con riesgo de disfemia se caracterizan por:

- Acompañarse de mayor tensión,
- Aparición de bloqueos en tensión.
- Aumentar la tasa de disfluencias
- Afectar en especial a la sílaba o parte de la palabra (disfluencia intrapalabra) más que a la frase (más frecuente y menos preocupante)

Si el niño:

- Tartamudea desde hace 6-12 meses o más.
- Empieza a tartamudear tarde (después de los 3½ años).
- Empieza a tartamudear con más frecuencia.
- Se pone tenso o le cuesta hablar.

- Evita hablar o dice que le cuesta mucho hablar.
- Tiene antecedentes familiares de tartamudez.

Es recomendable acudir a profesionales especializados.

2.1.2.3. Pausas

En lo que respecta a las pausas, la distinción se hace entre pausas silenciosas y pausas sonoras, también consideradas disfluencias o hesitaciones. Las pausas silenciosas sirven para respirar, para marcar los límites gramaticales y para dar tiempo a la planificación de nuevos materiales lingüísticos, siendo las que tienen una estructura funcional distintas de aquellas involucradas en la hesitación (Hernández y Gil, 2014).

Las pausas sonoras deben ser entendidas como un evento del lenguaje oral que, cuando son transcritas, pueden afectar a su entendimiento. Quien transcribe, lo hace de forma profundamente influenciada por la exposición excesiva de formas sintácticamente bien organizadas (Susanibar et al. 2019).

Finalmente, las diferencias entre tartamudear y los tipos de pausas, puede decirse que los tartamudeos ocurren en la palabra, predominantemente en la sílaba inicial o en el sonido inicial de las palabras mientras que las segundas ocurren entre las palabras. Al contrario que las pausas, los primeros impiden la sincronización de la respiración, la fonación, la articulación y el pensamiento, y rompen la regularidad rítmica del habla (Coll-Florit et al. 2014).

2.1.2.4. Prolongaciones

Los alargamientos o prolongaciones ocurrirán en los sonidos que se presenten para ello, observándose más frecuentemente cuando, por ejemplo, se habla por teléfono. Ocurren al principio de la palabra, al contrario que las disfluencias, y no están bajo el control del hablante (Sangorrín, 2005).

Las pausas silenciosas tienen consecuencias en las formas en las que le habla es procesada y en la representación de dicho. En común con las otras disfluencias, las pausas silenciosas interrumpen el proceso de comprensión. Por su parte, las pausas sonoras están asociadas a las prolongaciones por lo que las características segmentales y prosódicas constituyen importantes pistas para los oyentes.

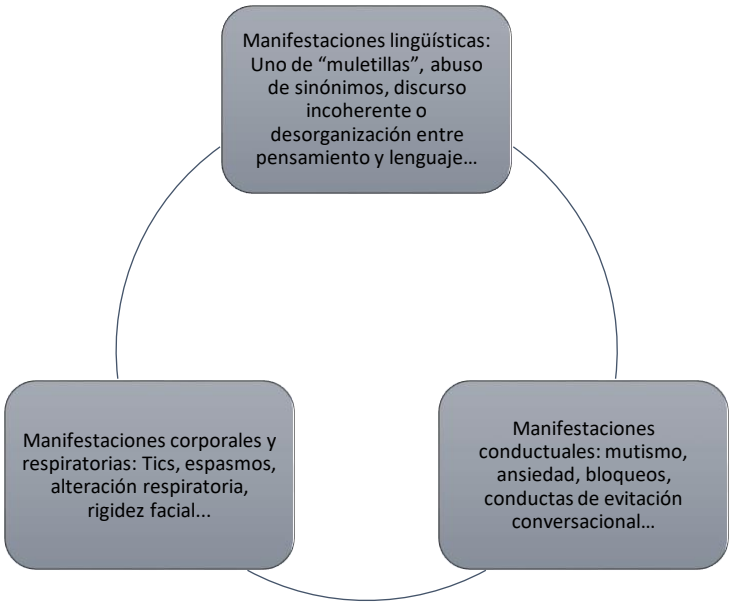
2.1.2.3. Manifestaciones de la disfemia

Las manifestaciones durante la disfemia pueden ser de tres tipos (véase Figura 3). Todas ellas se encuentran relacionadas con los factores del aprendizaje, los cuales, tal y como afirman, Susanibar et al. (2016), son conocidos como condicionamientos debido a las experiencias

negativas que proporciona, en muchas ocasiones, la alteración: condicionamiento clásico, operante y por evitación.

Figura 3.

Manifestaciones durante la disfemia (Susanibar et al., 2016)



Fuente: elaboración propia

En relación con los condicionamientos, el operante es el que está relacionado con niños, pues tiene que ver con la recompensa o el castigo asociado a un determinado momento. Es muy utilizado en la intervención, especialmente para reforzar los comportamientos que promueven la fluidez.

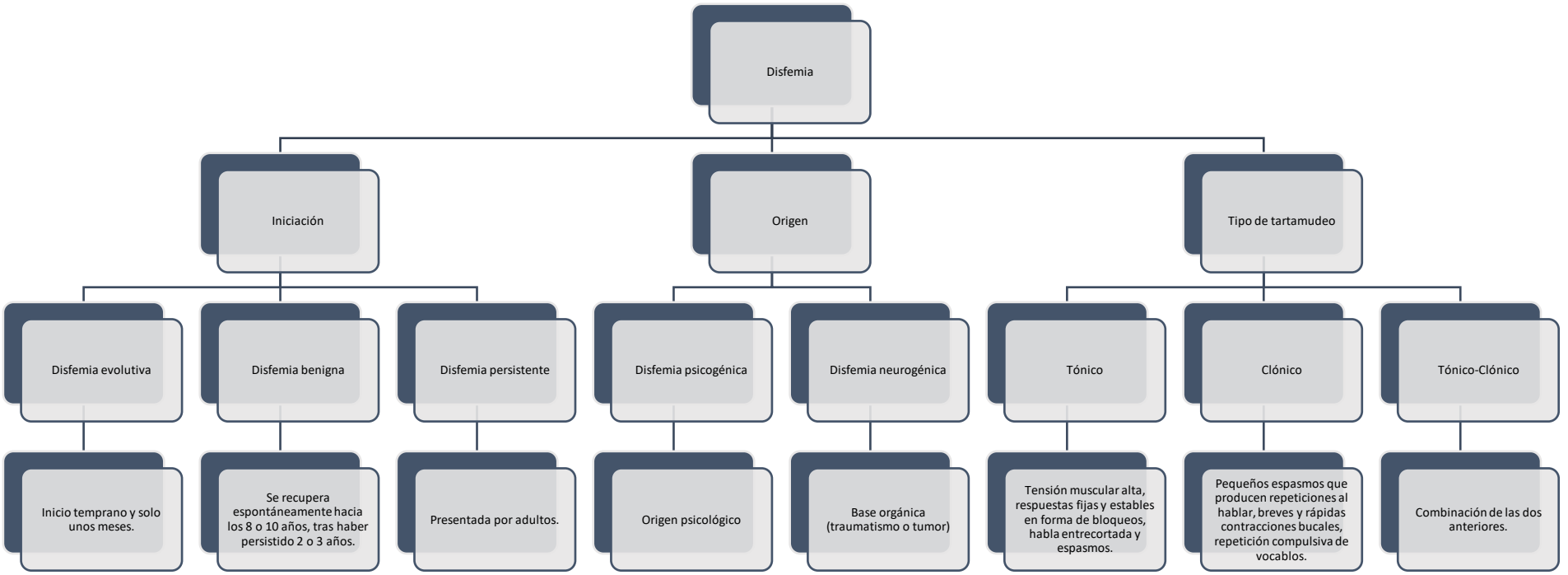
2.1.2.4. Taxonomía y prevalencia de la disfemia

Existen numerosas clasificaciones sobre la disfemia, las cuales se organizan teniendo en cuenta tres vertientes: iniciación, origen y tipo de tartamudeo (véase Figura 4).

Su aparición se produce entre los 2 y 5 años de edad. El inicio debe ser insidioso y transcurrir varios meses durante los cuales se produzcan alteraciones de la fluidez que se conviertan en un problema crónico.

Figura 4.

Clasificación de la disfemia (Coll-Florit et al., 2014)



Fuente: elaboración propia

2.1.2.5. Evaluación de la disfemia en preescolares

En lo que respecta a la evaluación de la disfemia, debe tenerse en cuenta si el profesional va a trabajar con niños preescolares o con niños escolares, pues en cada caso esta irá enfocada a un determinado ámbito y patrón.

En el primer caso, cuando se trabaja con niños preescolares y sus familias es importante recopilar cierta información preliminar sobre ellos y sus dificultades en el habla. Se trataría de determinar si el sujeto realmente está tartamudeando o si es una disfluencia normal. Tras descifrar este aspecto, podría pasarse a una observación directa.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que aun cuando el sujeto muestre una disfemia real, podría superarse en los primeros seis meses después del inicio, así que debería preguntarse a la familia cuánto tiempo el sujeto ha estado tartamudeando. Si, por el contrario, el sujeto muestra muchos signos que sugieren que es una disfluencia normal se aconseja posponer la evaluación algunos meses. Si, evidentemente, la disfluencia empeora o continua sin conseguir mejoras, la familia debería, en este caso, volver a llamar para una evaluación formal.

En relación con los instrumentos de evaluación o las pruebas y medidas, es importante tener varias pruebas disponibles como parte de la evaluación (véase Figura 5), pero, generalmente, deben aplicarse primero pruebas de lenguaje (i.e., sintaxis y vocabulario), para determinar si el niño tiene un problema en este proceso además de disfemia, además de una evaluación de la articulación para saber si se presenta algún inconveniente en este campo, ya sea fonológico o motor.

Figura 5.

Procedimiento de evaluación en preescolares (Susanibar et al. 2016)



2.1.2.6. Evaluación de la disfemia en escolares

En el caso de la etapa escolar, es mejor realizar una evaluación que dejar pasar el tiempo para ver si las dificultades desaparecen, pues se corre el riesgo de que la alteración empeore. Cuando se evalúa a un niño en edad escolar con disfemia se deben tener en consideración los siguientes casos:

- Cuando los padres o profesores se muestren preocupados por el habla del niño, ya que la actitud que ellos tengan ante el problema es un factor, como ya se sabe, que puede contribuir a mantener o agravar la dificultad.
- En caso de que se observen en el niño múltiples repeticiones, esfuerzo o tensión con bloqueos al hablar.
- Si el niño evita situaciones de comunicación por temor, se ataca o aparece ansiedad.
- En caso de que el niño presente diferencias en su comportamiento o en la comunicación, mostrándose más callado, recaído, triste o agresivo.
- Cuando el niño se queje de no poder controlar sus atascos y hablar fluido.

Una vez se haya podido descifrar lo anterior, se debe observar su forma de hablar para saber en qué medida es problemática. Para ello se necesitará observar los errores de fluidez, describirlos y analizarlos (bloqueos, repeticiones, prolongaciones, etc.).

Además, será necesario atender a otras conductas relacionadas que acompañan al lenguaje y al habla y que influyen en el tartamudeo como el nivel motor, el nivel lingüístico, los aspectos ambientales o el contexto comunicativo, ya que todo ello permitirá:

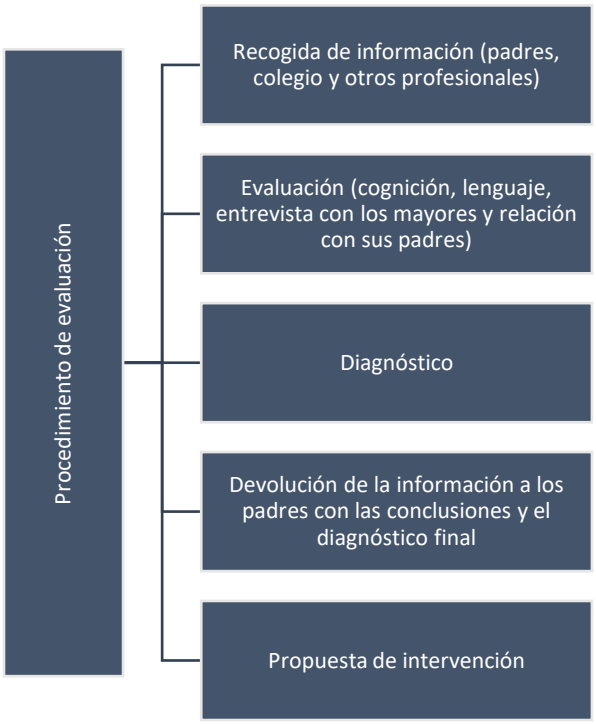
- Descartar problemas del desarrollo general del niño, así como otros problemas psicológicos paralelos a las dificultades en la fluidez.
- Describir de forma detallada las dificultades de fluidez:
    - Especificar situaciones donde el niño tiene mayor o menor dificultad construyendo una jerarquía que permita valorar los grados y programar, en base a ello, objetivos claros y cercanos en la intervención.
    - Evaluar la expresión del niño.
    - Evaluar la comunicación o relación con los padres, la familia, el colegio…etc. Es importante tener en cuenta que a los padres se les dedicará un apartado específico, como ya se vio, pues son una parte importante en el desarrollo y mantenimiento de la alteración.
    - Obtener una valoración de los padres, del grado de severidad y preocupación que tienen sobre el tartamudeo de su hijo.

- Analizar las consecuencias de la disfemia en el niño en término de emociones, pensamientos negativos, ansiedad, miedos…etc.
- Estimar la gravedad de la alteración en función del tipo de disfluencias, frecuencia, duración de las conductas asociadas…etc.
- Concluir con un diagnóstico que sea útil para fijar objetivos de intervención específicos para cada caso.

En lo que respecta al procedimiento, la evaluación de preescolares y escolares es similar, aunque difieren en la forma de abordar el problema (véase Figura 6).

Figura 6.

Procedimiento de evaluación en escolares (Coll-Florit et al. 2014)



Recuérdese que la edad de los escolares permite abordar directamente el tema de la tartamudez (siempre que el niño sea consciente de su problemática). El niño de preescolar, por su parte, por su desarrollo cognitivo, no es consciente del problema, no es capaz de expresar estados emocionales y cognitivos internos.

Finalmente, siguiendo a Asorey y Fernández (2014), los instrumentos más frecuentemente utilizados para evaluar las disfemias, y que se emplean complementariamente en la evaluación, son los analizadores de voz como el «Prat» (mediante el espectrograma se pueden conocer los formantes, la intensidad, la frecuencia fundamental, etc.).

2.1.2.7. Principales protocolos de Evaluación de la tartamudez

Los PRET-I y PRET-A son protocolos de evaluación desarrollados específicamente para la tartamudez (disfemia) desde un enfoque multidimensional. Su objetivo es valorar no solo la fluidez del habla, sino también las repercusiones emocionales, cognitivas y conductuales del trastorno.

- PRET-I (Protocolo de Evaluación de la Tartamudez Infantil) está dirigido a niños, generalmente en edades de Educación Infantil y primeros cursos de Primaria. Permite evaluar:
    - La frecuencia y tipología de las disfluencias.
    - La gravedad de la tartamudez.
    - Las conductas secundarias (movimientos asociados, tensión, evitación).
    - La repercusión funcional en diferentes contextos.
    - La información aportada por la familia y el profesorado.
- PRET-A (Protocolo de Evaluación de la Tartamudez en Adolescentes y Adultos) está diseñado para adolescentes y adultos. Además de analizar la fluidez del habla, incorpora la evaluación de:
    - Conductas de evitación y escape.
    - Impacto emocional y cognitivo de la tartamudez.
    - Actitudes hacia el habla.
    - Repercusión en la comunicación, la participación social y la calidad de vida.

No son pruebas psicométricas estandarizadas en el mismo sentido que el SSI-4 (Stuttering Severity Instrument-4). Se trata de protocolos clínicos de evaluación que ayudan a organizar la recogida de información y a planificar la intervención desde una perspectiva integral.

2.1.2.8. Intervención en disfemia: programas de intervención

La intervención que se realice en disfemia dependerá de la edad del sujeto y de las dificultades que muestre. Por un lado, se habla de una intervención temprana en la que se plantea una intervención de tipo preventivo que se lleva a cabo con niños de 2 a 6 años.

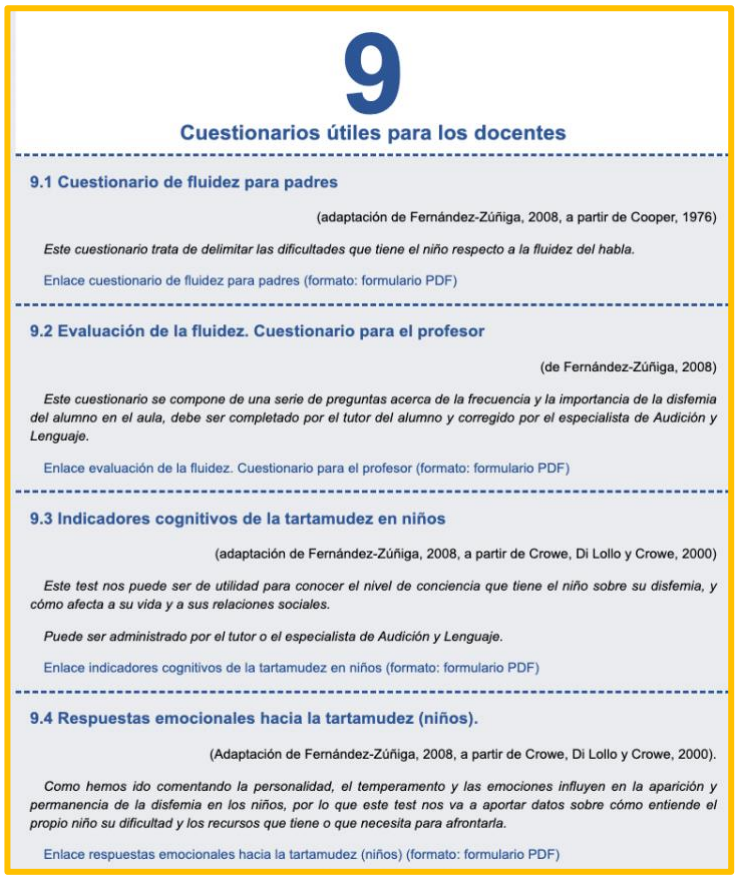
Habitualmente, en estos casos se realiza con un planteamiento indirecto, es decir, se abordan las dificultades del niño por medio de la interacción, del juego o modificando aspectos del contexto que puedan dificultar el habla fluida (Coll-Florit et al. 2014).

Por otro lado, los programas de intervención directa se utilizan generalmente con escolares y en estos se interviene directamente sobre la modificación del habla y se proporcionan recursos y cambios en el ambiente del niño (Asorey y Fernández, 2014).

Además, en ambos tipos de programas se realiza una intervención en paralelo con los padres, abordando cuestiones de un amplio abanico y no solo referidas al habla y la fluidez. También se realiza una orientación al profesorado *(véase Figura 7).*

Figura 7.

Guía de apoyo Disfemia: cuestionario para docentes (Región de Murcia, s.f.)



9

Cuestionarios útiles para los docentes

9.1 Cuestionario de fluidez para padres

(adaptación de Fernández-Zúñiga, 2008, a partir de Cooper, 1976)

Este cuestionario trata de delimitar las dificultades que tiene el niño respecto a la fluidez del habla.

Enlace cuestionario de fluidez para padres (formato: formulario PDF)

9.2 Evaluación de la fluidez. Cuestionario para el profesor

(de Fernández-Zúñiga, 2008)

Este cuestionario se compone de una serie de preguntas acerca de la frecuencia y la importancia de la disfemia del alumno en el aula, debe ser completado por el tutor del alumno y corregido por el especialista de Audición y Lenguaje.

Enlace evaluación de la fluidez. Cuestionario para el profesor (formato: formulario PDF)

9.3 Indicadores cognitivos de la tartamudez en niños

(adaptación de Fernández-Zúñiga, 2008, a partir de Crowe, Di Lollo y Crowe, 2000)

Este test nos puede ser de utilidad para conocer el nivel de conciencia que tiene el niño sobre su disfemia, y cómo afecta a su vida y a sus relaciones sociales.

Puede ser administrado por el tutor o el especialista de Audición y Lenguaje.

Enlace indicadores cognitivos de la tartamudez en niños (formato: formulario PDF)

9.4 Respuestas emocionales hacia la tartamudez (niños).

(Adaptación de Fernández-Zúñiga, 2008, a partir de Crowe, Di Lollo y Crowe, 2000).

Como hemos ido comentando la personalidad, el temperamento y las emociones influyen en la aparición y permanencia de la disfemia en los niños, por lo que este test nos va a aportar datos sobre cómo entiende el propio niño su dificultad y los recursos que tiene o que necesita para afrontarla.

Enlace respuestas emocionales hacia la tartamudez (niños) (formato: formulario PDF)

Fuente:Cuestiones útiles para los docentes. [Tabla] Por Fernández-Zúñiga, 2008. Recuperado de: https://www.carm.es/edu/pub/17018_2018/9_contenido.html

En relación con los programas de intervención, como se mencionaba, estos pueden dividirse en directos e indirectos. En el primero, se diseña un programa individualizado, donde se establezcan metas a corto y largo plazo, las técnicas a utilizar, el mantenimiento de la motivación, las tareas para casa y los pasos necesarios para la generalización.

1. Aspectos del programa de intervención directa:
    - Aprendizaje del control de habla: el alumnado debe conocer el proceso de habla normal para que pueda describir y analizar sus errores.

- Establecer una jerarquía de situaciones en función de los errores de fluidez y el grado de preocupación o ansiedad que generan esas situaciones.
- Controlar la ansiedad asociada a los momentos de comunicación para ir disminuyendo las situaciones de evitación o escape
- Técnicas cognitivas: mediante habilidades de reflexión se trata de que el alumno/a entienda las causas de sus dificultades y la forma de contrarrestarlas. Por medio de técnicas como "pensar en voz alta" o autoinstrucciones
- Entrenamiento en habilidades sociales para afrontar situaciones que le provoquen temor o ansiedad. Se trabajan las habilidades de escucha y las habilidades comunicativas para modificar sus conductas ante el grupo
- Generalización del nuevo patrón de habla aprendido en las sesiones a situaciones comunicativas reales.
- Hay que intentar que las actividades tengan una dimensión lúdica, para favorecer su comunicación espontánea en un ambiente lo más natural posible.
- Se debe tener siempre presente que la finalidad última es la generalización del nuevo patrón de habla a las situaciones comunicativas cotidianas.

Por su parte, el segundo va dirigido a la modificación del entorno del niño para que el trastorno no se agrave. Por ello, lo que se pretende con este tipo de intervención es modificar y eliminar los estresores que puedan estar influyendo en la aparición y mantenimiento de la alteración. Dentro de este tipo de intervención se encuentra la terapia de grupo, terapia de interacción madre/padre-hijo, prevención de la tartamudez temprana y terapia cognitivo-conductual.

2.1.2.9. Intervención directa en disfemia: tipología de actividades y papel del A.L.

En lo que respecta a la **tipología de ejercicios** que se puede plantear en **intervención directa**, esta **se organiza en seis bloques**: relajación, respiración, motricidad bucal, repetición y habla rítmica (veáse https://www.carm.es/edu/pub/17018_2018/8_contenido.html).

Finalmente, cabe mencionar que, dado que el maestro A.L. representará una referencia importante, será necesario realizar una intervención dirigida en el ambiente escolar que facilite una actitud adecuada frente a la disfemia, que enseñe al profesorado a hablar más lento y con una complejidad reducida, que favorezca la participación del sujeto en las actividades del aula o que gradúe, consecuentemente, las intervenciones para hacer que el niño vaya participando de situaciones más fáciles a más difíciles (Asorey y Fernández, 2014).

2.1.2.10. El rol de las familias

En lo que respecta a la intervención con los padres, esta es similar a la realizada con atención temprana, pero, en este caso, se debe hacer hincapié en otros aspectos como el ajuste de sus expectativas, la práctica diaria, los registros de conducta o los criterios de alta (Jácome, 2020).

BIBLIOGRAFÍA

Asorey, M. J. F., y Fernández, P. F. (2014). *Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo.* Ediciones Pirámide.

Carbajal, A., y Alfaro, V. (2020). Intervención en tartamudez en cuatro niños con diagnóstico de tartamudez del desarrollo de Lima metropolitana (Tesis Doctoral, Pontificia Universidad Católica del Perú).

Coll-Florit, M., Vila-Rovira, J. M., Aguado, G., Fernández-Zúñiga, A., Gambra, S., y Perelló, E. (2014). *Trastornos del habla y de la voz.* Barcelona: UOC.

Echeburúa, E., Salaberría, K., y Cruz-Sáez, M. (2014). Aportaciones y limitaciones del DSM-5 desde la Psicología Clínica. *Terapia psicológica, 32*(1), 65-74.

Fernández-Zúñiga, A., de León, M., y Moleres, S. G. (2011). Evaluación, intervención y evolución en un caso de tartamudez temprana. *Boletín de AELFA, 11*(2), 39-44.

Fernández-Zúñiga, A. (2008). *Cuestiones útiles para los docentes.* Región de Murcia. Recuperado de: https://www.carm.es/edu/pub/17018_2018/9_contenido.html

Hernández, J., y Gil, Y. (2014). Efectos de la retroalimentación auditiva retardada en los patrones de tartamudez. *Revista Ciencias de la Salud, 12*(2), 243-251.

Jácome, D. M. (2020). *Enfoque de tratamiento en la tartamudez temprana* (Tesis Doctoral, Universidad de Quito).

Jorquera, A., y Skoknic, V. (1982). Técnicas de relajación y sonido rítmico aplicadas al tratamiento del tartamudeo. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 2*(1), 32-38.

Leal, G., Junqueira, A., y Escobar, R. (2015). Nuevos desafíos en el tratamiento de la tartamudez. *Logopedia, 70(*1), 1-9.

Molina, J., Ampudia, M. S., Agulló, M. J., Guasch, L., y Tomás, J. (1999). Disfemia. *Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil*, (2), 115-124.

Morejón, A. R. (2001). Intervención sobre la tartamudez temprana. *Revista de logopedia, foniatría y audiología, 21*(1), 2-16.

Sangorrín, J. (2005). Disfemia o tartamudez. *Revista de neurología, 41*(1), 43-46.

Susanibar F., Dioses A., y Castillo J. (2014). Evaluación de Motricidad Orofacial. En: Susanibar F, Marchesan I, Parra D, Dioses A. (Coord.). *Tratado de evaluación de Motricidad Orofacial*. Madrid: EOS.

Susanibar, F., Dioses, A., Marchesan, I., Guzmán, M., Leal, G., Guitar, B., y Junqueira, A. (2016). *Trastornos del habla: de los fundamentos a la evaluación.* Madrid: Giunti EOS.

Susanibar, F., y Valdés, C. (2019). *Evaluación e Intervención logopédica en motricidad orofacial y áreas afines*. Madrid: Giunti EOS.

Valenzuela, M. (1990). Evaluación y tratamiento cognitivo-conductual de un caso de tartamudez. *Análisis y modificación de conducta, 16*(47), 137-148.